

Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	1/13	0

Nome do Procedimento: Consulta de rotina de Puericultura na Atenção Primária à Saúde (0 a 9 anos)

Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerências distritais da Atenção Primária

Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Atenção Primária à Saúde (APS)

Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Enfermeiro e Médico da Atenção Primária à Saúde

Objetivo(s): Orientar médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde sobre os tópicos a serem abordados na consulta programada do adolescente

Recursos necessários:

- Computador;
- Acesso à Internet;
- Acesso ao prontuário eletrônico;
- Estetoscópio;
- Esfigmomanômetro infantil e adulto;
- Fita métrica;
- Balança digital antropométrica;
- Tabela de Percentil de Pressão Arterial Sistêmica;
- Caderneta de Saúde do Adolescente;
- Computador.

1. DESCRIÇÃO

Pelo Ministério da Saúde, o acompanhamento de puericultura inicia desde o nascimento da criança até completar 10 anos de idade. A consulta de puericultura na Atenção Primária à Saúde (APS) consiste em um acompanhamento periódico da criança pelo médico e/ou enfermeiro da Unidade Básica de Saúde (UBSF), garantindo o desenvolvimento sadio nos aspectos físico, mental, nutricional, dentre outros.

Nos casos mais complexos de saúde que necessitam de intervenções especializadas, a equipe e-Multi e o pediatra de referência deverão fornecer apoio ao médico e ao enfermeiro da APS.

2. ETAPAS DA CONSULTA DE PUERICULTURA

As etapas da consulta de puericultura que devem ser seguidas são:

- Anamnese;



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	2/13	0

- Idade Corrigida;
- Antropometria, Sinais Vitais e Exame Físico;
- Avaliação da amamentação e/ou alimentação;
- Avaliação das vacinas;
- Orientação sobre cuidados e higiene;
- Orientações de prevenção de acidentes;
- Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento infantil;
- Exames de rotina.

Importante: A Caderneta de Saúde da Criança é um documento importante para acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento da criança, do nascimento até os 9 anos completos, servindo como apoio para orientação ao profissional e a família, além de ser obrigatório o preenchimento da mesma durante a consulta de puericultura.

A solicitação da caderneta deve ser feita pela UBSF ao Centro de Abastecimento de Materiais e Equipamentos (CAME) e em caso de falta da versão física, pode-se realizar a impressão digital através dos links: [Caderneta Menina](#) e [Caderneta Menino](#).

2.1. Anamnese

Objetivo: Obter o histórico de saúde da criança, incluindo condições do nascimento (tipo e local de parto, peso, estatura, perímetro cefálico, Apgar, idade gestacional – IG) e intercorrências clínicas. Também devem ser levantadas informações sobre alimentação, medicação, suplementação vitamínica, sono, etc.

Ação Principal: Classificar o risco em que a criança está exposta a partir das informações da anamnese e exame físico, para seguir o acompanhamento conforme o calendário de consultas específico, disponibilizado na Nota Orientativa nº 15/2025 – Calendário de Consultas de Puericultura e Odontologia de crianças de 0 a 9 anos completos e adolescentes de 10 a 19 anos completos, na Atenção Primária à Saúde (APS), disponível no Processo SEI nº 25.0.088137-1.

2.2. Avaliação da Idade Corrigida

Objetivo: É obrigatório a realização do cálculo de Idade Corrigida em todas as crianças prematuras, conforme Item 2.2.1 deste POP.

Orientações Gerais: Conforme o Ministério da Saúde, as orientações com relação a Idade Corrigida, são:



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	3/13	0

- Pré-termo **antes de 37 semanas de gestação**: a Idade Corrigida calculada deverá ser utilizada nas consultas **até os 2 anos** de vida.
- Pré-termo extremo **inferior a 28 semanas de gestação e/ou peso ao nascer inferior a 1000g**: a Idade Corrigida calculada deverá ser utilizada nas consultas **até os 3 anos** de idade cronológica.

Importante: A introdução alimentar em prematuros deve ser realizada com base na Idade Corrigida considerando sempre os sinais de prontidão neuromotora e não apenas a idade cronológica, a fim de garantir segurança e desenvolvimento adequado da alimentação.

Alguns procedimentos específicos deverão utilizar a Idade Corrigida calculada conforme Quadro 01.

Quadro 01. Procedimentos específicos utilizando idade corrigida de acordo com a prematuridade

PREMATURO < DE 28 SEMANAS	PREMATURO ≥ 28 A 37 SEMANAS
• Perímetro cefálico: até 3 anos • Peso: até 3 anos • Estatuta: até 3 anos • Avaliação Neurológica: até 3 anos	• Perímetro cefálico: até 2 anos • Peso: até 2 anos • Estatuta: até 2 anos • Avaliação Neurológica: até 3 anos

Fonte: Coordenação ESF

2.2.1. Como calcular a idade corrigida

- Verificar quantas semanas durou a gestação (ex.: IG 34 semanas);
- Subtraia de 40 semanas este valor. Ex.: 40 – 34 = 6 semanas;
- Transforme em meses: 4 semanas ≈ 1 mês; 6 semanas ≈ 1 mês e ½.

Importante: A **criança prematura** poderá recuperar o peso e o comprimento mais lentamente, atingindo a normalidade nas curvas de referência entre 2 a 3 anos, o que normalmente ocorre por volta dos 2 anos de idade, e o peso com 3 anos na idade corrigida. Nos casos de **RN extremo baixo peso** (PN < 1.000g) e/ou **extremos prematuros** (IG < 28 semanas) podem necessitar de mais tempo para essa recuperação.

2.3. ANTROPOMETRIA, SINAIS VITAIS E EXAME FÍSICO

Objetivo: Avaliar o estado nutricional, o crescimento da criança e identificar



Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 4/13	Anexos 0

anormalidades em diferentes partes do corpo.

Ações Principais:

- **Dados antropométricos** (peso, altura, IMC e perímetro cefálico): A antropometria ajuda a avaliar o estado nutricional e o crescimento;
- **Sinais vitais** (temperatura, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e saturação de oxigênio): indicam o estado de saúde geral e a resposta do organismo a possíveis problemas de saúde;
- **Exame físico completo**: permite identificar anormalidades em diferentes partes do corpo.

No Quadro 02 estão descritos os procedimentos a serem realizados de acordo com a idade cronológica.

Quadro 02. Procedimentos a serem verificados de acordo com a idade cronológica

PROCEDIMENTO	IDADE								
	1 MÊS	2 MESES	4 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES	24 MESES	3 ANOS OU MAIS
Antropometria	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Perímetro cefálico	X	X	X	X	X	X	X	X	
Exame físico	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avaliação de DNPM	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M-CHAT							X*		
Aferição de PA									X**
Avaliação puberal									X***
Teste do reflexo vermelho			X	X		X			
Acuidade visual									X**

*O M-CHAT/R pode ser aplicado entre 16 a 30 meses;

**A avaliação da Acuidade Visual deve iniciar a partir de 3 anos de idade e realizada anualmente;

***A aferição da PA deve iniciar a partir de 3 anos de idade e realizada anualmente, seguindo o POP 12 - Como Aferir e Interpretar os Valores da Pressão Arterial em Criança e Adolescente (Processo SEI nº 25.0.088137-1);

***A avaliação puberal deve iniciar a partir dos 8 anos em meninas e 9 anos em meninos, ou antes seguindo o POP Consulta de rotina do Adolescente na Atenção Primária à Saúde (10 a 19 anos) (Processo SEI 25.0.088137-1).

Fonte: Adaptado pela Coordenação ESF, COREN SC-2020

2.4. Avaliação da Amamentação e Alimentação Complementar

Objetivo: Avaliar o aleitamento materno e os hábitos alimentares da criança, registrando as informações no prontuário eletrônico (SIG SaudeTech), preenchendo o Formulário de Consumo Alimentar no prontuário eletrônico (SIG-Saudetech), conforme



Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 5/13	Anexos 0

orientações disponíveis no *SEI* 22.0.059839-9.

Ações Principais:

- Avaliar se o aleitamento materno é exclusivo (recomendado nos primeiros 6 meses) e se continua sendo mantido (recomendado até os dois anos ou mais), conforme orientações do link [Guia Alimentar Para Crianças Brasileiras Menores De 2 Anos](#);
- Identificar o uso de fórmula infantil, leite de vaca ou outros;
- Orientar sobre a introdução alimentar a partir dos 6 meses. No início, a criança deverá receber a comida amassada com garfo, em forma de purê, sendo fornecida com auxílio de uma colher.
- Aos 8 meses, deve-se evoluir para alimentos picados em pedaços pequenos, raspados ou desfiados, para que a criança aprenda a mastigá-los.
- Preencher o Formulário de Consumo Alimentar que consta no prontuário eletrônico em toda consulta até os 2 anos de idade;
- No caso de crianças maiores de 2 anos, avaliar os grupos de alimentos consumidos com frequência e hábitos a serem incentivados ou modificados, preenchendo anualmente o Formulário de Consumo Alimentar que consta no prontuário eletrônico.

Importante:

- Orientações com relação a amamentação e alimentação complementar, podem ser consultadas nos links:
 - [Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos](#)
 - [Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 - Versão Resumida](#)
- Em caso de dificuldades no manejo da amamentação, a Unidade de Saúde poderá solicitar auxílio para os seguintes serviços:
 - [Tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil \(EAAB\)](#): O Processo SEI nº 24.0.184179-7 disponibiliza o documento orientativo e a lista de tutores da Estratégia;
 - **Unidade Ligue Web Saúde**: Encaminhar através do formulário eletrônico <https://bit.ly/3WSv5t8>, as lactantes com dificuldades de amamentação que buscaram atendimento na unidade de saúde e necessitam de acompanhamento;
 - **Banco de Leite da maternidade Darcy Vargas**: A UBSF ou os responsáveis poderão agendar avaliação através do telefone: 3481-0151 / 3481-1302. Em caso de **situações urgentes** como abscesso mamário, lesões na mama, obstrução de ducto mamário e ingurgitamento severo, a usuária deverá



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 6/13	Anexos 0
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

acessar o Banco de Leite da MDV através da emergência da MDV.

- No POP “Primeira Avaliação do Recém Nascido (RN) e Puérpera até o 5º dia de Vida da Criança (Primeira Semana de Saúde Integral), também estão descritas orientações a respeito da amamentação (Processo SEI nº 21.0.211798-1).

2.4.1. Fórmulas Infantis e Leites Modificados

Nem sempre é possível amamentar, seja por questões patológicas, fisiológicas ou sociais. Para casos clínicos específicos, o município fornece fórmulas especiais descritas no “Protocolo de Acesso à Fórmulas e Suplementos Nutricionais” (Processo SEI nº 24.0.180839-0).

Casos de vulnerabilidade social/baixa renda que não se enquadram nos critérios clínicos do protocolo, deverão ser referenciadas ao CRAS e orientada a utilização de leites modificados, conforme Quadro 03.

Quadro 03. Diluição de Leite de Vaca

PRODUTO	DILUIÇÃO (para crianças até 3 meses e 29 dias)	ORIENTAÇÃO
Leite de vaca integral	Utilizar aproximadamente 2/3 de leite fluido + 1/3 de água fervida. Exemplos: 70ml de leite + 30ml de água = 100ml; 100ml de leite + 50ml de água = 150ml; 130ml de leite + 70ml de água = 200ml.	É necessário, em cada diluição, o acréscimo de 1 (uma) colher de chá de óleo para cada 100 ml de leite , pois a diluição do leite de vaca diminui o ácido linoleico e a densidade energética.
Leite de vaca em pó integral	Utilizar as proporções de diluição sugeridas: 1 colher de sobremesa rasa para 100ml de água fervida; 1½ colher de sobremesa rasas para 150ml de água fervida; 2 colheres das de sobremesa rasas para 200ml de água fervida	

Importante:

- A criança alimentada com leite de vaca modificado precisa receber suplementação de vitaminas e minerais, com a prescrição e orientação de profissionais de saúde conforme “Nota Técnica da Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso, Carbonato de Cálcio e Vitamina A + Vitamina D pelo Médico, Enfermeiro, Nutricionista e/ou Farmacêutico na assistência à Pré-concepção, Pré-natal e Puericultura” (Processo SEI nº 25.0.207373-6);
- Leite de vaca em pó ou líquido diluído podem ser utilizados para crianças até 3 meses e 29 dias. A partir do 4º mês, não há mais necessidade de diluição e a alimentação complementar deve ser iniciada;
- Toda criança em uso de leite de vaca diluído e de fórmulas ou suplementos fornecidas pelo Município deve ser avaliada **mensalmente** pela equipe da APS.



Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 7/13	Anexos 0

2.5. Avaliação do Calendário Vacinal

Objetivo: Verificar o cartão de vacina em todas as consultas e garantir que as doses aplicadas estejam em dia, conforme o [link](#) do [Calendário de Imunização](#) do Ministério da Saúde.

Ações Principais: Se houver recusa da família na aplicação das vacinas, o profissional deverá solicitar ao responsável legal da criança, o preenchimento do [Termo de Recusa de Vacina](#), disponível no processo SEI nº 25.0.006611-2 e notificar o Conselho Tutelar via *e-mails* oficiais, conforme [Quadro 04](#):

Quadro 04. Informações sobre os Conselhos Tutelares

Nome do Conselho	E-mail oficial	Bairro atendidos
Conselho Tutelar 1	sas.ctu1@joinville.sc.gov.br	Paranaguamirim, Ulysses Guimarães, Jarivatuba, Adhemar Garcia, Parque Guarani, João Costa (Região Sudeste)
Conselho Tutelar 2	sas.ctu2@joinville.sc.gov.br	Centro, Anita Garibaldi, Bucarein, Guanabara, Fátima, Atiradores, Itaum, América, Saguazu, Glória, Boa Vista, Iriú, São Marcos (Região Centro)
Conselho Tutelar 3	sas.ctu3@joinville.sc.gov.br	Itinga, Boehmerwald, Profipo, Santa Catarina, Petrópolis, Nova Brasília, Morro do Meio, Floresta (Região Sudoeste)
Conselho Tutelar 4	sas.ctu4@joinville.sc.gov.br	Vila Nova, Costa e Silva, Santo Antônio, Zona Industrial Norte, Jardim Sofia, Pirabeiraba, Dona Francisca, Rio Bonito, Bom Retiro (Região Noroeste)
Conselho Tutelar 5	sas.ctu5@joinville.sc.gov.br	Aventureiro, Comasa, Espinheiros, Jardim Iriú, Jardim Paraíso, Vila Cubatão, Zona Industrial Tupy (Região Nordeste)

Orientações detalhadas sobre o funcionamento do Conselho Tutelar estão descritas na Carta de Serviço disponibilizada em <https://www.joinville.sc.gov.br/institucional/sas/ctu/>.

2.6. Orientação Sobre Cuidados Gerais

Objetivo: Fornecer orientações específicas para a família sobre cuidados essenciais e higiene, conforme a idade da criança.

Temas Gerais Abordados:

Conforme idade da criança, em todas as consultas deverá ser orientado sobre:

- Cólicas;



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	8/13	0

- Higiene (banho) e cuidados em saúde bucal, orientar sobre escovação, higiene e encaminhamento para avaliação odontológica seguindo a Linha de Cuidado da Saúde Bucal (Processo SEI nº 20.0.152438-7);
- Troca de fraldas e prevenção de assadura;
- Prevenção da morte súbita e posição para dormir nos primeiros meses de vida, conforme demonstra a Figura 01 (Processo SEI nº 22.0.113758-1);
- Prevenção de acidentes conforme faixa etária da criança, considerando seu desenvolvimento neuropsicomotor;
- Amamentação e Alimentação;
- Uso de repelentes, exposição ao sol e uso de filtro solar;
- Manobra De Heimlich em situações de engasgo (Infográfico Primeiros Socorros - SEI 24.0.273544-3);
- Orientação à família para o uso de telas e o estímulo da criança para brincadeiras adequadas para a idade.

Figura 01. Posição para dormir nos primeiros meses de vida

Dormir de barriga para cima é mais seguro!

É possível reduzir em mais de 70% a morte súbita de bebês. Para isso:

- **Coloque o seu bebê para dormir de barriga para cima.**
- **Amamente:** até o 6º mês dê somente leite materno.
- **Não fume e nem deixe que fumem dentro da sua casa,** principalmente durante a gestação e na presença de crianças pequenas.
- **Não agasalhe demais o bebê.**
- **Deixe fora do berço travesseiros, brinquedos, almofadas e outros objetos fofos.**

Mais informações em www.pastoraldacrianca.org.br

Apoiem esta campanha:

Ministério da Saúde | UNICEF | PROJETO APOIADO PELO CNBB | ESPERANÇA

Fonte: Ministério da Saúde, 2009



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 9/13	Anexos 0

2.6.1. Temas Específicos

2.6.1.1. *Exposição ao Sol*

Durante os seis primeiros meses de vida, os bebês não devem ser expostos diretamente ao sol.

A partir dos seis meses e até o primeiro ano de vida, as exposições solares devem ser:

- Curtas e em horários específicos: até às 10h e após às 16h, e
- Sempre com a utilização de protetor solar apropriado: filtros solares infantis, que geralmente contêm menos substâncias químicas prejudiciais à pele da criança.

2.6.1.2. *Uso de telas*

Questionar a família sobre o tempo de uso de telas pela criança e orientar que uso excessivo ou inadequado de telas pode provocar alterações no sono, risco de obesidade, sedentarismo, aumento dos índices de ansiedade e depressão, distúrbios de atenção, atraso no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, miopia, riscos de abuso e vitimização sexual, ameaças à privacidade e de uso de dados pessoais, além de risco de vícios em jogos eletrônicos e uso de aplicativos.

Orientações sobre o uso de tela podem ser consultadas por meio do link da [Cartilha de Uso Inteligente de Tecnologia](#).

2.7. Orientações para Prevenção de Acidentes

Objetivo: Orientar a família sobre a prevenção de acidentes, considerando que estes variam conforme a faixa etária e a fase de desenvolvimento da criança.

Principais Causas de Acidentes por Faixa Etária: Os acidentes podem ocorrer conforme faixa etária e a fase de desenvolvimento da criança, conforme descritos no Quadro 05.

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 10/13	Anexos 0

Quadro 05: Principais causas de acidentes conforme faixa etária

IDADE	CAUSAS DE ACIDENTES
Menores de 2 anos	• Quedas; • Queimaduras; • Intoxicações.
Pré-escolares (de 2 a 6 anos)	• Atropelamentos; • Afogamentos; • Quedas de Lugares Altos; • Ferimentos; • Queimaduras.
Crianças na idade escolar (de 6 a 10 anos)	• Atropelamentos; • Quedas de Bicicletas; • Quedas de Lugares Altos; • Traumatismos Dentários; • Ferimentos com Armas de Fogo.

2.8. Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil

Objetivo: Avaliar e registrar o desenvolvimento da criança seguindo a Caderneta da Criança, que deve ser preenchida em todas as consultas, obrigatoriamente.

Ações Principais: Registrar as principais aquisições e a percepção dos pais/responsáveis em relação ao desenvolvimento global da criança (motor, linguagem, socialização e habilidades). O registro deverá ser realizado tanto no prontuário eletrônico SIG Saúde Tech quanto nos 'Marcos do Desenvolvimento Infantil' da Caderneta da Criança."

2.9. Solicitação de Exames de Rotina

Objetivo: Delinear a conduta de solicitação de exames sempre considerando a anamnese (histórico de saúde da gestação materna, da criança e da família), pois até o momento, não há indicações de exames de rotina para crianças).

Recomendações Específicas:

- **Hemograma**

Recomenda-se o rastreamento sistemático para anemia apenas para crianças de risco, conforme "Nota Técnica Conjunta - Prescrição de Ácido Fólico, Sulfato Ferroso,

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 11/13	Anexos 0

Carbonato de Cálcio e Vitamina A +Vitamina D pelo Médico, Enfermeiro,Nutricionista e/ou Farmacêutico na assistência à Pré-concepção, Pré-natal e Puericultura” disponível no Processo SEI nº 25.0.207373-6.

- **Perfil Lipídico**

Recomenda-se pesquisar o perfil lipídico (colesterol, HDL, triglicerídeos e LDL) a partir dos 2 anos de idade, a cada 3 a 5 anos, em crianças cujos pais ou avós apresentaram doença cardiovascular precoce (antes de 55 anos para homens e 65 anos para mulheres) ou cujos pais possuem níveis elevados de colesterol total.



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	12/13	0

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, nº 33- **Saúde da criança: Crescimento e Desenvolvimento**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília, 2012. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Linhas de Cuidado. **Puericultura e Hebicultura**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/puericultura/>

BRASIL. **Lei da “Cadeirinha”**. Conselho Nacional de Trânsito. Disponível através do link: <https://criancasegura.org.br/noticias/transito/lei-da-cadeirinha-saiba-tudo-sobre-essa-importante-regra-de-seguranca-no-transito/>

BRASIL. Acidentes na infância: 90% podem ser evitados com medidas simples de prevenção. Disponível através do link: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/acidentes-na-infancia-90-podem-ser-evitados-com-medidas-simples-de-prevencao>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos**. Brasília, 2021. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf

Brasil.**Criança Segura**. Disponível em: <https://criancasegura.org.br/noticias/transito/lei-da-cadeirinha-saiba-tudo-sobre-essa-importante-regra-de-seguranca-no-transito/>

Paraná. **Lives para Capacitação em Puericultura**. Disponível: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Puericultura#:~:text=Puericultura%20consiste%20em%20um%20acompanhamento,f%C3%ADsico%20e%20mental%2C%20nutricional%2C%20dentre>

São Paulo. **Seguimento Ambulatorial Do Prematuro De Risco**. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/seguimento_prematuro_ok.pdf

São Paulo. Sociedade Brasileira de Pediatria. **Fotoproteção na Criança**, 2018. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/cuidados-com-a-saude/fotoprotecao-na-crianca/>



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.065	Versão nº 01	Página 13/13	Anexos 0
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Fernanda Cristina Spiller; Janaina Pravato Vicente Banin.	2025 Andressa Backes Emanuela Reiser; Emanuela Reiser; Janine Guimarães; Sarah Jacinto; Valquiria Aparecida Duarte; Willian Waldelino Custódio da Silva.	2025 Cibely Schipitoski; Juliana Antunes Safanelli; Luana Garcia Ferrabone; Vanessa Cardoso Pacheco.

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 25.0.088137-1

Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde:

<https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/protocolos-pops-e-outros-documentos-da-saude/>

Alteração após Revisão

Versão	Data	Responsável	Alteração
02			
03			

